LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM

Vũ Hồng Tuân, TS. Nguyễn Việt Hoa

MỤC TIÊU

1. Trình bày được nguyên nhân và cấu tạo lồng ruột.

2. Tổng hợp được các triệu chứng lâm sàng và đề xuất được biện pháp cận lâm sàng chẩn đoán lồng ruột.

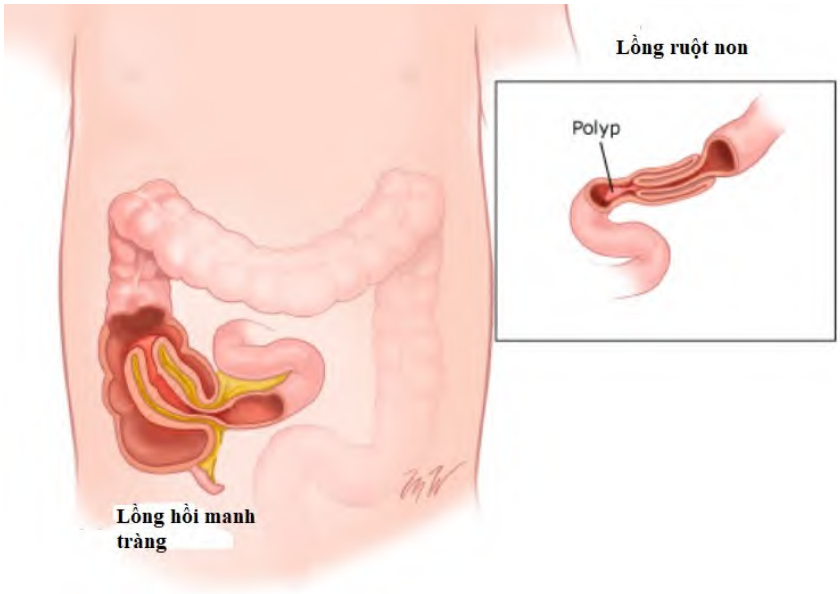
3. Thực hiện đúng qui trình điều trị lồng ruột ở trẻ em.

I. TỔNG QUAN

1. Đại cương

Lồng ruột (LR) là hiện tượng đoạn ruột chui vào lòng của đoạn ruột kế cận, thường là lồng ruột theo chiều nhu động, ít gặp thể bệnh đoạn ruột dưới lồng vào đoạn trên.

Bệnh có nhiều hình thái khác nhau có thể gây nên hội chứng tắc ruột cơ học và nghẹt ruột làm cản trở lưu thông của đường tiêu hóa và cản trở tuần hoàn mạch máu ruột. Nếu không được điều trị kịp thời có thể gây biến chứng hoại tử ruột, sốc nhiễm trùng thậm chí tử vong nếu không chẩn đoán và xử trí sớm.



Hình 1. Lồng ruột [Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

Lịch sử bệnh đã được biết đến từ thời Hyppocrate, và từ thế kỷ XVIII trở về trước thì hầu hết là tử vong. Năm 1871, Hutchison báo cáo ca đầu tiên mổ lồng ruột thành công ở trẻ em. Năm 1876 Hirschprung đã báo cáo kinh nghiệm điều trị tháo lồng bằng nước với tỷ lệ tử vong là 35%, cũng là thấp hơn nhiều so với mổ tháo lồng. Từ năm 1927, bắt đầu có báo cáo sử dụng thuốc cản quang tháo lồng bởi các bác sỹ chẩn đoán hình ảnh. Năm 1959, Fiorito thực hiện tháo lồng bằng hơi. Năm 1977, Burke và Clarke sử dụng siêu âm trong chẩn đoán và theo dõi tháo lồng ruột. Nhờ những tiến bộ đó mà việc chẩn đoán và điều trị lồng ruột có nhiều tiến bộ và tỷ lệ tử vong rất thấp.

2. Dịch tễ học

- Tuổi: LR là một cấp cứu ngoại khoa rất thường gặp ở trẻ em, với tỉ lệ 1,57/1000 - 4/1000 trẻ. Mặc dù LR có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào, nhưng 75% trường hợp xảy ra ở trẻ dưới 2 tuổi, 90% trường hợp dưới 3 tuổi và đặc biệt hay gặp ở thời kỳ 4 - 9 tháng tuổi (40%).

- Giới: Hay gặp ở trẻ nam hơn nữ, tỷ lệ nam/nữ từ 3/2 → 2/1.

- Thể trạng và chế độ ăn: Hay gặp ở trẻ bụ bẫm, bú sữa mẹ.

- Thời tiết: Hay gặp nhiều bệnh nhân vào mùa đông xuân.

- Yếu tố bệnh lý: LR cấp sau ỉa chảy, viêm nhiễm đường hô hấp.

3. Nguyên nhân

3.1. Lồng ruột thứ phát *(có nguyên nhân thực thể):* Tỷ lệ 2-8%, thường gặp ở trẻ lớn trên 5 tuổi chiếm 75-90%, còn ít tìm thấy nguyên nhân thực thể ở nhóm nhỏ hơn 2 tuổi. Các nguyên nhân thực thể hay gặp là:

- Túi thừa Meckel là nguyên nhân hay gặp.

- Polype hồi tràng, manh, đại tràng.

- Các khối u ác tính, u máu trong lòng ruột.

- Ruột đôi ở góc hồi manh tràng.

- Nhân tụy lạc chỗ.

Ngoài ra, các bệnh lý toàn thân như u lympho, ban xuất huyết dạng thấp, bệnh viêm quánh niêm dịch, bệnh nhân đang được điều trị hóa trị cũng là các yếu tố nguy cơ cao làm cho lồng ruột xuất hiện.

3.2. Lồng ruột nguyên phát *(không có nguyên nhân thực thể):* Nhóm này thường gặp ở trẻ nhũ nhi từ 3 tháng đến 2 tuổi, nguyên nhân thường liên quan đến một tình trạng rối loạn nhu động ruột mà bệnh căn chưa rõ. Một số giả thuyết được đưa ra:

- Thuyết do virus, vi khuẩn: Những công trình nghiên cứu gần đây cho rằng virus gây viêm hạch mạc treo làm rối loạn phản xạ thần kinh thực vật và gây nên lồng ruột. Bell.T.M (1962), Steyn J.H (1962) đã phân lập được virus từ hạch mạc treo của trẻ em lồng ruột. Ross.J.G (1961), Gardenr.P.S (1962) đã xác định được trong các hạch này

loại Adenovirus nhóm 1, 2, 3, 5, 6 và Echovirus nhóm 7, 9. Các virus này có thể thấy ở miệng, dịch bài tiết của màng tiếp hợp và trong phân.

- Thuyết giải phẫu: Do sự không cân xứng về kích thước giữa hồi tràng và manh tràng. Trước tháng thứ 4 hồi tràng và hồi mạnh tràng có kích thước không khác nhau lắm, trong khoảng từ tháng thứ 4 đến tháng 12 manh tràng phát triển to nhanh hơn nhiều, do đó có sự khác nhau rõ rệt về mức độ di động giữa hồi tràng và manh tràng. Thuyết này cắt nghĩa được vì sao lồng ruột hay gặp trong khoảng từ 4 đến 9 tháng và vì sao lồng ruột thường thấy ở khu vực hồi manh tràng.

Việc thay đổi chế độ ăn từ lỏng sang đặc khiến cho ruột của trẻ chưa thích ứng kịp, khiến nhu động ruột không đều nên ruột dễ chui vào nhau hoặc là tình trạng nhiễm siêu vi trùng đường ruột làm tăng nhu động ruột cũng được cho là yếu tố tạo thuận lợi cho lồng ruột xuất hiện. Ngoài ra, còn nhiều yếu tố khác như yếu tố thần kinh, giới tính (lồng ruột ở bé trai hay gặp hơn ở bé gái)… cũng là yếu tố nguy cơ gây lồng ruột.

4. Cấu tạo khối lồng và tổn thương giải phẫu bệnh

4.1. Khối lồng

- Cắt dọc một khối lồng đơn giản thấy:

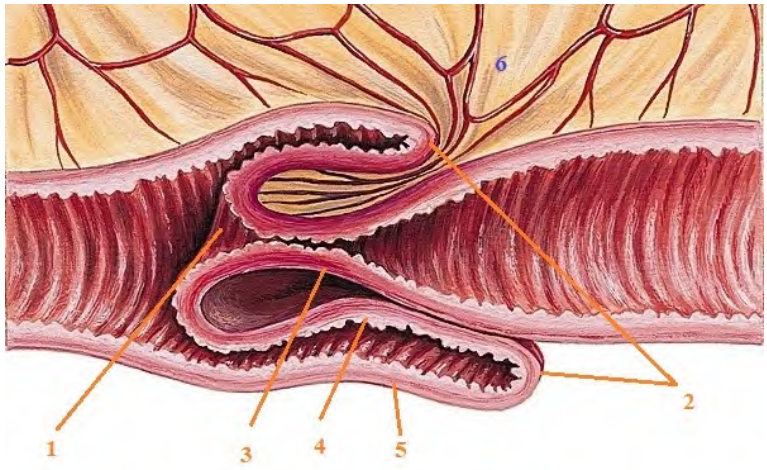
+ 3 lớp: Ngoài, giữa, trong.

+ 1 đầu: Là khởi điểm của khối lồng.

+ 1 cổ: Nối tiếp giáp giữa lớp giữa và lớp trong.

+ Mạc treo nuôi dưỡng: Kẹt giữa lớp giữa và lớp trong. Cổ khối lồng càng hẹp, mạch nuôi dưỡng càng bị cản trở dẫn đến hoại tử ruột.

- Hiếm gặp: 1 khối lồng phức tạp: 2 đầu, 2 cổ, 5 lớp.



Hình 2. Sơ đồ cắt dọc khối lồng [nguồn: Internet]

1. Đầu khối lồng; 2. Cổ khối lồng; 3. Lớp trong; 4. Lớp giữa;

5. Lớp ngoài; 6. Mạc treo ruột

4.2. Chiều lồng

- Đa số đoạn ruột trên chui vào đoạn ruột dưới theo chiều nhu động.

- Hiếm gặp lồng ruột giật lùi do giun đũa: Đoạn ruột trên do nhu động quá mạnh ôm phủ đoạn ruột dưới.

4.3. Thương tổn giải phẫu bệnh lý

- Khối lồng làm tắc lòng ruột và cản trở mạch máu nuôi dưỡng đoạn ruột lồng.

- Thương tổn tùy thuộc:

+ Thời gian phát hiện và điều trị (sớm, muộn).

+ Cổ khối lồng (rộng, hẹp).

- Khi mổ thấy tổn thương:

+ Ổ bụng: Có dịch trong hoặc đục.

+ Ruột trên chỗ lồng: Giãn chứa hơi, dịch.

+ Mạc treo ruột: Nhiều hạch viêm, phù dày hay lấm chấm xuất huyết.

+ Khối lồng: Phù nề, tím hay hoại tử và thủng.

5. Sinh lý bệnh của lồng ruột: Lồng ruột gây nên hai biến đổi về sinh lý:

5.1. Cản trở lưu thông của đường tiêu hoá

Khối lồng làm tắc lòng ruột gây ứ đọng hơi và dịch trong lòng ruột ở phía trên chỗ lồng. Khi có biểu hiện tắc ruột, bệnh nhi nôn nhiều gây mất nước và điện giải kèm theo các rối loạn sinh lý khác.

5.2. Cản trở tuần hoàn của đoạn ruột lồng

Ngay từ đầu của khối lồng, mạc treo của đoạn ruột lồng bị ép giữa các lớp của khối lồng, cản trở lưu thông máu tĩnh mạch. Các tĩnh mạch mạc treo đoạn ruột lồng bị ứ máu và ruột lồng bị phù nề, gây chép ép tĩnh mạch. Niêm mạc của đoạn ruột lồng nhanh chóng bị tổn thương và chảy máu. Máu kết hợp với chất nhầy do niêm mạc ruột tiết ra tạo thành chất nhầy lẫn máu gây nên hiện tượng phân nhày máu. Áp lực máu động mạch lúc đầu còn cao hơn ở tĩnh mạch, nên khối lồng còn được nuôi dưỡng, về sau áp lực máu tĩnh mạch cao lên, không còn chênh lệch giữa động mạch và tĩnh mạch nữa, tuần hoàn ngừng trệ và hoại tử xuất hiện. Ruột bị hoại tử lúc đầu ở lớp giữa, sau đến lớp trong của khối lồng.

6. Phân loại lồng ruột

6.1. Theo nguyên nhân

- Lồng ruột nguyên phát: Chiếm đa số các trường hợp 75%-90%.

- Lồng ruột thứ phát: Chiếm khoảng 5% - 20%.

- Lồng ruột sau mổ.

6.2. Theo vị trí giải phẫu

Các hình thái theo giải phẫu bệnh của lồng ruột được xác định bởi điểm khởi đầu của lồng ruột và vị trí ruột bị lồng vào.

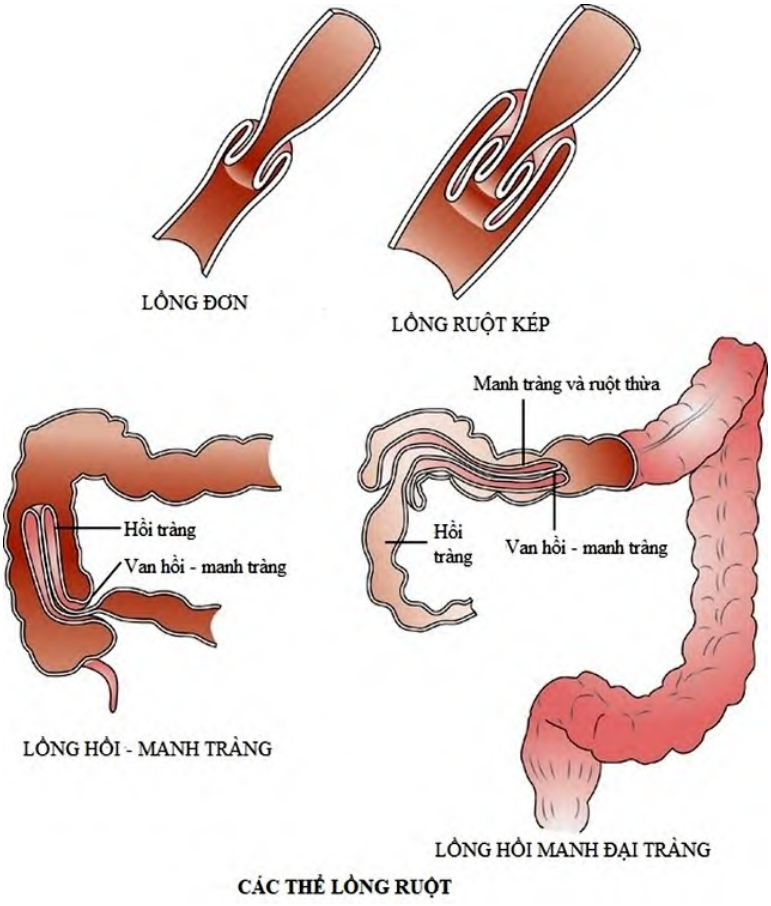
Trong lồng ruột, có thể gặp lồng ruột non (hỗng - hỗng tràng, hỗng - hồi tràng, hồi - hồi tràng), hay lồng ruột già (manh - đại tràng, đại - đại tràng). Nhưng hay gặp nhất là các trường hợp lồng phần cuối hồi tràng vào manh tràng hay đại tràng. 95% lồng ruột có đầu lồng là van Bauhin hoặc hồi tràng gần góc hồi manh tràng. Các thể lồng hay gặp là:

Lồng ruột hồi - đại tràng: Đầu khối lồng là hồi tràng gần góc hồi manh tràng, ruột thừa nằm ngoài khối lồng, loại này chiếm 85% lồng ruột.

Lồng ruột hồi - hồi - đại tràng: Đầu khối lồng là góc hồi manh tràng. Van Bauhin tạo nên đầu khối lồng. Ruột thừa và manh tràng đẩy đầu khối lồng tiến sâu vào lòng đại tràng, chiếm khoảng 10%.

Lồng ruột manh - đại tràng, đại - đại tràng: Ruột thừa và manh tràng nằm trong khối lồng, chiếm khoảng 2,5%. Lồng ruột thừa - manh tràng hiếm gặp.

Lồng ruột hỗng - hỗng tràng, hồi - hồi tràng: Chiếm khoảng 2,5%.



Hình 3. Các thể lồng ruột [Nguồn: Thomas Mobley, 2010]

6.3. Theo số lần bị lồng ruột

- Lồng ruột tiên phát

- Lồng ruột tái phát

6.4. Theo tính phức tạp của khối lồng

- Lồng ruột đơn (đơn giản): Khối lồng chỉ có 3 ống (Lồng ruột hồi - hồi tràng, đại - đại tràng, hồi - đại tràng, hồi - manh tràng…).

- Lồng ruột kép (phức tạp): Khi khối lồng có nhiều hơn 3 ống (Lồng ruột hồi - hồi - đại tràng; Lồng ruột ruột thừa - manh - đại tràng; Lồng ruột hồi - manh - đại tràng…), khó tháo lồng.

II. CHẨN ĐOÁN LÂM SÀNG

1. Lồng ruột ở trẻ còn bú (≤ 24 tháng tuổi): Thường là lồng ruột cấp tính.

A. Triệu chứng sớm

Triệu chứng cơ năng: Trẻ bụ bẫm đột nhiên:

• Đau bụng cơn: Đột ngột, dữ dội, biểu hiện bệnh nhân ưỡn người, khóc thét từng cơn, mỗi cơn kéo dài 3-10 phút. Sau cơn đau bệnh nhân mệt ngủ thiếp đi. Khi thức dậy trẻ có thể bú một ít rồi lại lên cơn đau tiếp theo, thời gian giữa các cơn đau khoảng từ 15 phút tới 30 phút.

• Nôn: Thường xuất hiện sau cơn đau đầu tiên, chất nôn là sữa hoặc thức ăn vừa ăn vào. Nếu thời gian bị lồng ruột đã kéo dài, bệnh nhân có thể nôn ra dịch mật.

• Ỉa ra máu: Trung bình 6-8 giờ sau cơn khóc đầu tiên có thể phân lẫn máu hoặc có chất nhầy lẫn máu.

Triệu chứng toàn thân: Ít thay đổi (không sốt, chưa có dấu hiệu mất nước).

Triệu chứng thực thể:

• Khối lồng: Là dấu hiệu đặc hiệu nhất, sờ thấy khối lồng hình quai ruột nằm theo khung đại tràng (ở dưới bờ sườn phải hoặc ngang trên rốn hoặc sang tới dưới bờ sườn trái, hố chậu trái), ấn vào khối lồng thường bệnh nhân đau. Để tìm được khối lồng, phải khám nhẹ nhàng khi bệnh nhân nằm yên, ngoài cơn đau.

• Hố chậu phải rỗng: Chỉ thấy khi đến sớm và ít có giá trị.

• Thăm trực tràng: Có thể máu theo tay, bóng trực tràng rỗng, có thể thấy đầu khối lồng.

B. Triệu chứng muộn: Là một bệnh cảnh tắc ruột rõ hoặc viêm phúc mạc có ỉa máu:

Triệu chứng cơ năng:

- Cơn khóc kéo dài nhưng ít dữ dội hơn.
- Nôn ra nước mật, nước phân.
- Ỉa máu nâu đen nhiều lần.

Triệu chứng toàn thân: Dấu hiệu mất nước, nhiễm trùng, nhiễm độc (môi khô, mắt trũng, sốt cao, lờ đờ, tím tái...).

Triệu chứng thực thể:

- Bụng trướng, khó sờ được khối lồng. khám có thể thấy dấu hiệu quai ruột nổi, rắn bò. Trong trường hợp viêm phúc mạc có thể thấy dấu hiệu cảm ứng phúc mạc.
- Thăm trực tràng: Có máu nâu đen, có thể sờ được đầu khối lồng.

2. Lồng ruột ở trẻ lớn: Thường là lồng bán cấp hoặc mạn tính.

- Đau bụng: Thường kéo dài từng đợt, các cơn đau thưa ít, khoảng vài cơn đau mỗi ngày, vẫn trung tiện được. Mỗi đợt đau kéo dài 2-6 ngày rồi hết đau. Sau đó lại tái xuất hiện và những đợt đau như vậy có thể kéo dài hàng tháng.

- Nôn hoặc buồn nôn: Ít gặp nôn trong lồng ruột mạn tính. Tính chất nôn là thức ăn hoặc dịch mật.

- Đại tiện máu: Ít gặp trong lồng ruột mạn tính.

- Khối lồng: Xuất hiện từng đợt, trong cơn đau, ngoài cơn đau có thể không sờ thấy. Sau một thời gian khối lại thấy cùng với cơn đau bụng. G.Leward gọi khối lồng sờ thấy trong lồng ruột bán cấp và mạn là khối "u ma" (Tumeur fantome).

- Toàn trạng: Trẻ luôn mệt mỏi, kém ăn, có thể suy dinh dưỡng.

III. CHẨN ĐOÁN CẬN LÂM SÀNG

Lồng ruột có thể được chẩn đoán dựa vào lâm sàng, tuy nhiên thăm khám cận lâm sàng không những rất có giá trị trong chẩn đoán xác định lồng ruột mà còn giúp chẩn đoán nguyên nhân và tiên lượng khối lồng chặt hay lỏng.

1. X quang bụng không chuẩn bị: Ít có giá trị chẩn đoán, có vai trò trong phát hiện các biến chứng lồng ruột.

- Hình khối mờ hạ sườn phải.
- Không có hơi ở manh tràng.
- Mức nước - hơi.
- Liềm hơi (khi khối lồng hoại tử thủng).



Hình 4. X quang bụng không chuẩn bị bệnh nhân lồng ruột
[Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

A. Hình ảnh tắc ruột với các quai ruột giãn;

B. Hình ảnh lồng ruột là khối mờ ở đầu mũi tên

2. Chụp X quang đại tràng

Chụp X quang đại tràng kết hợp bơm hơi hay thụt thuốc cản quang barit nhằm hai mục đích: vừa chẩn đoán và điều trị (tháo lồng). Tuy nhiên hiện nay ít sử dụng thụt barit.

Các hình ảnh của lồng ruột thường gặp:

+ Hình đáy chén.

+ Hình càng cua.

+ Hình hình móc câu

+ Hình cắt cụt.

+ Một số nguyên nhân của lồng ruột như: Polype, u đại tràng…

Ngày nay do độ phổ biến, tiện lợi của siêu âm nên người ta chỉ dùng chụp đại tràng với bơm hơi vào mục đích điều trị khi chẩn đoán đã rõ.



Hình càng cua



Hình cắt cụt của đại tràng

Hình 5. X quang đại tràng bệnh nhân lồng ruột
[Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

3. Siêu âm

Hình ảnh siêu âm của lồng ruột được báo cáo lần đầu tiên năm 1977 ở hai bệnh nhân người lớn bởi Weissberg và cộng sự cùng với Burke và Clark, sử dụng siêu âm với đầu dò tần số cao (7,5 - 9 MHz) hoặc siêu âm Doppler để phát hiện được khối lồng. Hình ảnh siêu âm của lồng ruột ở trẻ em được báo cáo đầu tiên năm 1982, khi Bowerman và cộng sự ghi nhận dấu hiệu hình bia ở 3 bệnh nhân. Năm 1985, Swischuk và cộng sự đã mô tả hình bia trên mặt cắt ngang và hình giả thận trên mặt cắt dọc ở 14 trẻ em bị LR. Swischuk cho rằng khi có những dấu hiệu này, chẩn đoán LR nên được nghĩ tới.

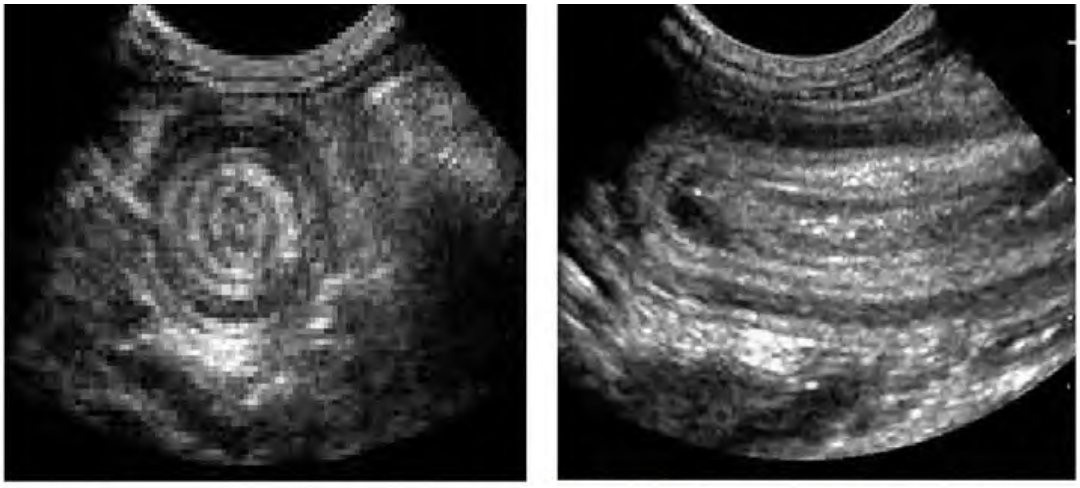
- Hình ảnh khối lồng trên siêu âm:

+ Cắt ngang: Hình vòng bia, vòng tròn trong đậm âm, vòng tròn ngoài ít âm.

+ Cắt dọc: Hình bánh kẹp nhân (bánh Sandwich) hay hình "giả thận", khối đậm âm ở giữa được viền quanh bởi một vành ít âm.

- Vị trí khối lồng: Thường nằm hung hạ sườn phải, dọc khung đại tràng, những khối lồng nằm ngoài khung đại tràng → lồng ruột non.

- Đôi khi thấy nguyên nhân gây lồng ruột: Khối u, túi thừa Meckel, búi giun...



Hình bia bắn trên siêu âm cắt ngang qua khối lồng

Hình bánh Sandwich trên siêu âm cắt dọc qua khối lồng

Hình 6. Hình ảnh siêu âm của lồng ruột [Nguồn: Tác giả]

- Giá trị của siêu âm tiên lượng khối lồng chặt khi:

+ Đường kính khối lồng ≥ 35mm.

+ Chiều dày thành ruột lồng > 8mm.

+ Có dịch trong lòng khối lồng và dịch tự do ổ bụng.

- Siêu âm Doppler màu đánh giá có dòng chảy trong lòng các mạch máu của khối lồng hay không, tưới máu thành ruột giúp liên quan đến chỉ định phẫu thuật.

4. Nội soi tiêu hóa

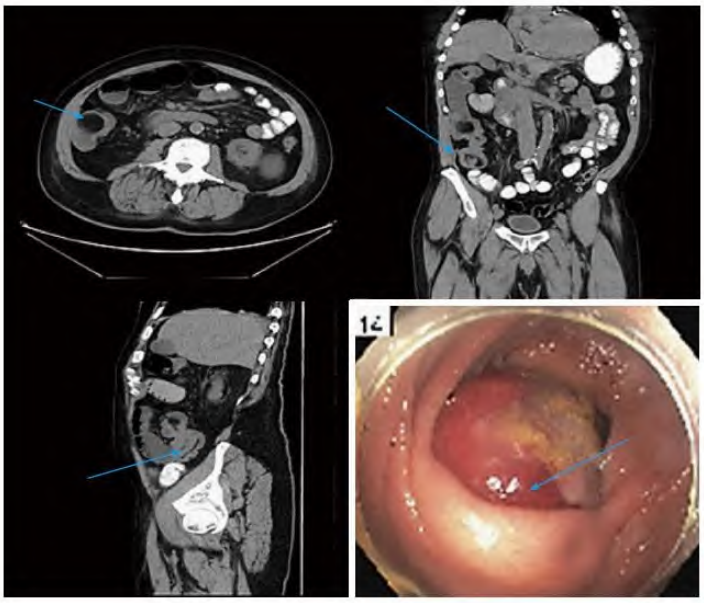
- Nội soi đại tràng giúp chẩn đoán lồng ruột.

- Tìm thấy nguyên nhân của lồng ruột (nếu có). Soi đại tràng bằng ống mềm có thể chẩn đoán được lồng ruột và giúp chẩn đoán nguyên nhân thực thể ở đại tràng như u, polype. Nếu có polype, cắt bằng nội soi kết hợp bơm hơi đại tràng tháo lồng có thể điều trị lồng ruột và tránh tái phát.

- Trong chẩn đoán lồng ruột, nội soi tiêu hóa chủ yếu được áp dụng khi lồng ruột tái phát nhiều lần, lồng ruột mạn tính, có dấu hiệu nghi ngờ của u đại tràng hoặc polype đại tràng… Tuy nhiên, nội soi đại tràng thường không được chỉ định trong cấp cứu.

5. Chụp cắt lớp vi tính

Chụp cắt lớp vi tính thường được chỉ định trong lồng ruột tái phát nhiều lần mà nghi ngờ có nguyên nhân thực thể như: u ruột, u lympho… Hoặc lồng ruột đến muộn khó chẩn đoán.



Hình 7. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính và soi đại tràng
[Nguồn: Santosh Shenoy, 2017]

Đầu mũi tên chỉ khối lồng kèm polype

IV. CHẨN ĐOÁN

1. Chẩn đoán xác định lồng ruột

- Đau bụng cơn + nôn + khối lồng.

- Đau bụng cơn + nôn + ỉa máu + khối lồng.

- Đau bụng cơn + nôn + ỉa máu.

- Đau bụng cơn + chẩn đoán hình ảnh có khối lồng (X quang hoặc siêu âm).

2. Chẩn đoán phân biệt

- Hội chứng lỵ: Bệnh nhân có cảm giác mót rặn, đại tiện nhiều lần, phân có ít máu và chất nhầy.

- Đau bụng, tắc ruột do giun: Đau bụng cơn, không ỉa máu, nắn thấy quai ruột có giun đũa.

- Rối loạn tiêu hóa: Đau bụng quanh rốn, phân lỏng, nắn bụng thường mềm.

- Viêm phổi: Nghe phổi thấy ran, chụp phổi thấy thương tổn.

- Viêm ruột hoại tử: Đau bụng, phân lỏng có máu thối khẳn, thường có dấu hiệu sốc.

- Chảy máu tiêu hóa: Tùy theo nguyên nhân gây chảy máu mà có những dấu hiệu lâm sàng tương ứng.

- Viêm ruột thừa, viêm túi thừa Meckel, viêm ruột, u bụng.

3. Diễn biến của lồng ruột cấp

- Một số rất ít trường hợp tự tháo, còn tất cả các trường hợp cần phát hiện và điều trị sớm.

- Nếu không xử lý sẽ dẫn đến hoại tử ruột (do mạc treo bị cổ khối lồng thắt nghẹt) → viêm phúc mạc → tử vong.

V. ĐIỀU TRỊ

1. Các yếu tố tiên lượng

- Các triệu chứng lâm sàng có giá trị tiên lượng khối lồng khó tháo:

+ Tuổi: Tuổi càng nhỏ đặc biệt trẻ < 4 tháng tuổi: Khối lồng thường chặt.

+ Thời gian bị lồng ruột: Kéo dài trên 48 giờ, hoặc trên 72 giờ.

+ Thời gian xuất hiện ỉa máu càng sớm, đặc biệt ≤ 5 giờ và lượng máu ra nhiều thì khối lồng càng khó tháo.

+ Đã có hội chứng tắc ruột rõ, đã có rối loạn tại chỗ (bụng trướng, nắn đau) hoặc rối loạn toàn thân (sốt cao, mất nước, sốc).

- Giá trị tiên lượng của siêu âm: Khối lồng chặt khi:

+ Đường kính khối lồng từ 35 mm

+ Chiều dày thành ruột lồng > 8 mm

+ Có dịch trong lòng khối lồng và dịch tự do trong ổ bụng.

2. Tháo lồng không mổ

Hiện nay có nhiều phương pháp tháo lồng không mổ như: Thụt chất cản quang vào đại tràng, thụt đại tràng bằng các dung dịch đẳng trương dưới hướng dẫn của siêu âm, bơm hơi đại tràng…

2.1. Phương pháp dùng chất cản quang để thụt tháo lồng: Retan và Stephens mô tả lần đầu từ năm 1927. Nhược điểm của phương pháp này là barite rất độc cho cơ thể khi có biến chứng vỡ đại tràng làm barite trào vào ổ bụng. Chống chỉ định tuyệt đối của thụt barite đại tràng là bệnh nhân có biểu hiện viêm phúc mạc. Vì nhược điểm trên của phương pháp thụt barite, hiện nay một số tác giả đã nghiên cứu thay thế bằng thụt một loại dung dịch iod cản quang tan trong nước và không độc hại như gastrografine, télébrix gastro.

Nhược điểm chung của các phương pháp điều trị bằng thụt các dung dịch cản quang tháo lồng theo dõi trên màn chiếu huỳnh quang là cả bệnh nhân và thầy thuốc đều phải chịu một lượng tia phóng xạ khá lớn trong quá trình tháo lồng.

2.2. Phương pháp dùng nước thường để thụt: Cũng được mô tả từ lâu (Baldwin năm 1852 và Hirschprung năm 1876), tuy nhiên đây là dung dịch nhược trương với máu, không tốt cho trẻ. Dung dịch nước thường được thay thế bằng dung dịch muối đẳng trương như nước muối sinh lý NaCl 0,9% hoặc dung dịch đa điện giải

đẳng trương (dung dịch Hartmann có chứa K^+ từ 3-5 mmol/l và Na^+ từ 130-150 mmol/l) để thụt. Các dung dịch này lại không cản quang nên khó theo dõi đánh giá kết quả. Tuy nhiên, những năm gần đây, siêu âm với đầu dò tần số cao và siêu âm màu Doppler đã cho phép kiểm tra hướng dẫn rất tốt cho thủ thuật này.

2.3. Phương pháp tháo lồng bằng hơi: Hay áp dụng nhất, đơn giản.

- Phương tiện theo dõi: Dưới màn huỳnh quang tăng sáng hoặc siêu âm.

- Chỉ định: Đến sớm ≤ 48 giờ, chưa có dấu hiệu viêm phúc mạc.

- Kỹ thuật:

+ Tiền mê hoặc gây mê.

+ Bơm hơi áp lực 90 mmHg ở trẻ nhỏ và 100-110 mmHg ở trẻ lớn.

+ Theo dõi trên lâm sàng, dưới màn huỳnh quang hoặc siêu âm.

- Tiêu chuẩn tháo lồng: Dựa vào:

+ Lâm sàng:

Bụng trướng đều.

Áp lực bơm tụt đột ngột.

Không còn sờ thấy khối lồng.

+ Màn huỳnh quang hoặc siêu âm:

Mất hình ảnh khối lồng.

Hơi sang ruột non.

- Theo dõi sau tháo lồng:

+ Bình thường: Sau tháo lồng trẻ bú tốt, không nôn sau 6-8 giờ ỉa phân vàng.

+ Phát hiện các biến chứng: Sốt cao, tháo chưa hết, vỡ ruột…



Hình 8. Tháo lồng ruột bằng bơm hơi [Nguồn: Nghia "Jack" Vo, Up to date 2020]

A. Khối lồng trước tháo; B. Khối lồng được tháo và hơi tràn vào ruột non; C. Biến chứng vỡ ruột khi tháo (hơi ra tự do ổ bụng)

- Chăm sóc sau tháo lồng:

+ Sau tháo lồng, trẻ hết nôn, có thể cho trẻ uống nước đường, sau đó uống sữa. Trường hợp trẻ còn nôn, đặt sonde dạ dày giảm áp dịch và hơi trong đường tiêu hoá, nhịn ăn uống và truyền dịch.

+ Thời gian nằm viện 12-48 giờ. Sau thủ thuật 24 giờ, thực hiện siêu âm ổ bụng kiểm tra trước khi ra viện.

3. Tháo lồng bằng phương pháp mổ

Hiện nay, có hai phương pháp tiếp cận phẫu thuật trong xử trí khối lồng: Phẫu thuật nội soi và phẫu thuật mở. Sự lựa chọn phương pháp nào tùy thuộc vào phẫu thuật viên, gây mê hồi sức và từng trường hợp cụ thể.

- Chỉ định mổ:

+ Tháo lồng bằng phương pháp bơm hơi không có kết quả.

+ Đến muộn > 48 giờ hoặc có dấu hiện viêm phúc mạc.

- Kỹ thuật mổ:

+ Mê nội khí quản.

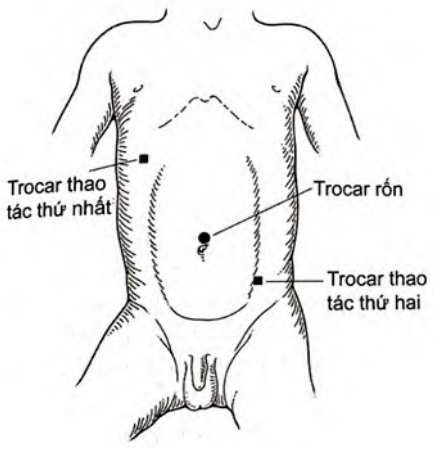
3.1. Mổ nội soi tháo lồng

- Vị trí đặt 3 trocar: Trocar rốn cho ống kính soi và hai trocar cho dụng cụ thao tác, thường được đặt ở hố chậu trái và dưới sườn trái hoặc dưới sườn phải.

- Lần theo rãnh đại tràng tìm khối lồng.

- Dùng kẹp phẫu tích cặp ruột phía trên khối lồng và dùng một kẹp phẫu tích khác kéo nhẹ nhàng đoạn ruột bị lồng để tháo lồng.

- Trong trường hợp khó khăn có thể dùng một panh nong rộng cổ khối lồng để thao tác dễ dàng hơn.



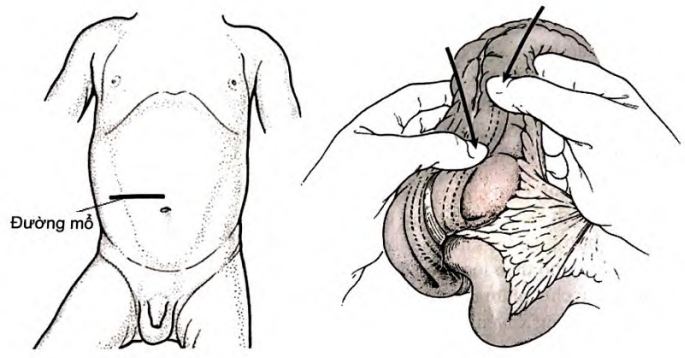
Hình 9. Vị trí đặt trocar [Nguồn: Apelt, 2014]

+ Sau khi tháo, kiểm tra cẩn thận tổn thương ruột, có hay không tình trạng hoại tử ruột và thủng ruột. Có thể cắt ruột thừa và cố định manh tràng vào thành bụng trong các trường hợp lồng ruột tái phát có manh tràng di động.

+ Những trường hợp khối lồng quá chặt, khó tháo qua nội soi thì nên đưa ruột ra ngoài ổ bụng để kiểm tra khởi điểm lồng qua vị trí mở rộng trocar rốn hoặc mở nhỏ vị trí bụng tương ứng khối lồng.

3.2. Mổ mở tháo lồng

- Đường mổ: Đường ngang bụng phải, trên hoặc dưới rốn tùy thuộc vào vị trí của khối lồng; hoặc đường trắng giữa trên và dưới rốn.



Hình 10. Đường mổ mở và thao tác tháo lồng bằng tay [Nguồn: Apelt, 2014]

- Đưa khối lồng ra ngoài thành bụng, đánh giá khả năng sống của ruột. Nếu khối lồng chưa hoại tử, tiến hành tháo lồng bằng tay bằng cách nắn vào đầu khối lồng. Sau khi tháo lồng, sờ nắn ruột để tìm nguyên nhân lồng ruột.

- Trong trường hợp khối lồng ruột đã hoại tử hoặc khối lồng không thể tháo bằng tay, hoặc ruột hoại tử sau khi tháo, hoặc có nguyên nhân gây lồng ruột: túi thừa Merkel, nang ruột đôi, polype ruột… thì phải tiến hành cắt ruột. Sau cắt ruột, có thể nối ruột ngay nếu tình trạng bệnh nhi cho phép. Nếu toàn trạng bệnh nhân quá nặng, nên đưa hai đầu ruột ra ngoài tạm thời và sẽ đóng lại thì hai.

- Chăm sóc sau mổ: Ống thông dạ dày, truyền dịch, kháng sinh.

- Phát hiện các biến chứng sau mổ: Chảy máu, tắc bục miệng nối…

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nghia "Jack" Vo, MD, Thomas T Sato, MD, FACS, FAAP, *Intussusception in children*, Uptodate Mar 2020 (WWW.Uptodate.com).
2. Marsicovetere, P., et al. (2017). *Intestinal Intussusception: Etiology, Diagnosis, and Treatment.* Clin Colon Rectal Surg. 30(1): p. 30-39.
3. Yap Shiyi E, Ganapathy S. (2017). *Intussusception in Children Presenting to the Emergency Department: An Asian Perspective.* Pediatr Emerg Care; 33:409,
4. West KW, Grosfeld JL. (1999). *Intussusception. In: Pediatric Gastrointestinal Disease: Pathophysiology, Diagnosis, Management*, Wyllie R, Hyams JS (Eds), WB Saunders, Philadelphia. p.427
5. Nguyễn Thanh Liêm (2015), *"Lồng ruột",* Phẫu thuật nội soi trẻ em, Nhà xuất bản Y học, tr.33-36.
6. Bines JE, Liem NT, Justice FA, et al. (2006). *Risk factors for intussusception in infants in Vietnam and Australia: adenovirus implicated, but not rotavirus*. J Pediatr; 149:452
7. Trần Ngọc Bích (2006), *"Lồng ruột ở trẻ bú mẹ và trẻ em",* Cấp cứu ngoại khoa, tập 1, Nhà xuất bản Y học, tr.425-438.

8. Apelt, N., N. Featherstone, and S. Giuliani. (2013). *Laparoscopic treatment of intussusception in children: a systematic review.* J Pediatr Surg, 48(8): p. 1789-93.
9. Gupta H, Davidoff AM, Pui CH, et al. (2007). *Clinical implications and surgical management of intussusception in pediatric patients with Burkitt lymphoma*. J Pediatr Surg; 42:998.
10. Hadidi AT, El Shal N. (1999). *Childhood intussusception: a comparative study of nonsurgical management.* J.Pediatr Surg; 34:304.

CÂU HỎI LƯỢNG GIÁ

Câu 1. Anh (chị) hãy trình bày nguyên nhân và cấu tạo khối lồng ruột?

Câu 2. Anh (chị) hãy trình bày chẩn đoán (lâm sàng và cận lâm sàng) lồng ruột ở trẻ em?

Câu 3. Anh chị hãy trình bày nguyên tắc điều trị lồng ruột cấp ở trẻ em?

Câu 4. Anh chị hãy trình bày qui trình bơm hơi tháo lồng điều trị lồng ruột cấp ở trẻ em?

Câu 5. Anh chị hãy trình bày qui trình phẫu thuật tháo lồng điều trị lồng ruột ở trẻ em?